

CIRUGIA ABDOMINAL COLOSTOMIA ILEOSTOMIA

VUELVE A MOVERTE

Guía de ejercicio y recuperación activa con estoma



RESPIRACION

FUERZA

MOVILIDAD

CONFIANZA

Tu estoma no te impide entrenar

Programa gradual, individualizado y coordinado con cirugía, enfermería estomaterapeuta y rehabilitación

EMPIEZA DESDE TU SITUACION REAL

COMO USAR ESTA GUIA

La seguridad no significa inmovilidad: significa progresar con criterio

01

A quien va dirigida

ADULTOS CON COLOSTOMIA O ILEOSTOMIA

A personas con un estoma reciente o ya consolidado, temporal o permanente. Tambien ofrece adaptaciones si existe un abultamiento o una hernia paraestomal.



02

Antes de empezar

TU EQUIPO TIENE LA ULTIMA PALABRA

- Sigue primero las restricciones concretas de tu cirujano y enfermera estomaterapeuta.
- Si la operacion es reciente, confirma que la herida evoluciona bien y que puedes caminar y respirar sin mareo.
- Individualiza si hubo complicaciones, cirugia perineal, anemia, quimioterapia, dolor importante o debito alto.

03

Cuatro reglas que protegen

APLICALAS EN CADA REPETICION

RESPIRA

Expulsa el aire durante el esfuerzo. No bloquee la respiracion.

ACTIVA

Tension abdominal suave, sin hundir con fuerza ni provocar un bulto alrededor del estoma.

PROGRESA

Cambia una sola variable: tiempo, repeticiones, serie o resistencia.

OBSERVA

Si al dia siguiente estas claramente peor, vuelve al nivel anterior.

La evidencia especifica sobre estomas aun es limitada; muchas recomendaciones combinan estudios pequenos y consenso experto.

NO ES UN CALENDARIO RIGIDO

TU MAPA DE RECUPERACION

Avanza por objetivos, no solo por semanas

01

0-2 SEMANAS

RECUPERAR

Respiracion, bombeo de tobillos, giro en bloque y paseos cortos. Activacion abdominal muy suave si estas estable y autorizado.

02

2-6 SEMANAS

COORDINAR

Aumenta poco a poco los paseos. Practica movilidad, postura y control abdominal. Recupera tareas ligeras sin contener el aire.

03

6-12 SEMANAS

FORTALECER

Con herida cerrada y revision favorable: fuerza 2 dias por semana, bandas, bicicleta y piscina solo cuando todo haya cicatrizado.

04

MAS DE 12

VOLVER

Progresas hacia tu trabajo, gimnasio o deporte. Las cargas altas y el impacto requieren fuerza, tecnica y buena gestion de la presion.

Semaforo para progresar



VERDE

Sin dolor, sin mareo y sin aumento de bulto: continua.



AMBAR

Molestia leve o mas fatiga: repite el nivel o reduce.



ROJO

Dolor, fuga repetida, mareo o bulto nuevo: para y consulta.

PRIMEROS DIAS Y PRIMERAS SEMANAS

EMPIEZA POR AQUI

Movimientos sencillos para recuperar autonomia sin miedo



01

Respiracion diafragmatica

5 CICLOS 3-5 VECES AL DIA

- 1 Tumbado con rodillas flexionadas, pon una mano en pecho y otra en abdomen.
- 2 Inspira por la nariz; al soltar el aire, activa suavemente la zona baja.

CLAVE La respiracion debe seguir fluida.



02

Bombeo de tobillos

10-20 REPETICIONES

- 1 Siéntate con la espalda apoyada y ambos pies delante.
- 2 Alterna elevar puntas y talones sin prisa.

CLAVE Util tambien tras periodos sentado.



03

Giro en bloque

EN CADA ENTRADA Y SALIDA

- 1 Dobra las rodillas y gira hombros y caderas juntos hacia un lado.
- 2 Saca las piernas y empujate con los brazos mientras sueltas el aire.

CLAVE Evita incorporarte haciendo un abdominal.



04

Paseos cortos

5-10 MIN 2-4 VECES AL DIA

- 1 Camina erguido a un ritmo que permita hablar con facilidad.
- 2 Aumenta 2-5 minutos cuando termines bien y al día siguiente no empeores.

CLAVE Varias dosis cortas tambien cuentan.

CONTROL ANTES QUE INTENSIDAD

REHABILITA TU CORE

El objetivo es coordinar respiracion, abdomen y suelo pelvico



01 Activacion abdominal

5-10 REP 3-5 SEG

- 1 Rodillas flexionadas y manos en la parte baja del abdomen.
- 2 Suelta el aire y genera una tension suave, como abrochar un pantalon.

CLAVE Sin aplastar la bolsa ni contener el aire.



02 Basculacion pelvica

1-2 SERIES 8-10 REP

- 1 Desde la misma posicion, acerca suavemente la zona lumbar al suelo.
- 2 Mantiene 2-3 segundos respirando y vuelve.

CLAVE El movimiento es pequeno y comodo.



03 Rodillas a un lado

1-2 SERIES 6-8 POR LADO

- 1 Con pies juntos, mueve ambas rodillas unos centimetros hacia un lado.
- 2 Mantiene hombros relajados y vuelve al centro al exhalar.

CLAVE Reduce el recorrido si tira la cicatriz.



04 Puente bajo

1-2 SERIES 6-10 REP

- 1 Activa suave y eleva la pelvis solo hasta donde controles.
- 2 Baja despacio sin que aparezca abultamiento alrededor del estoma.

CLAVE Introduce mas tarde si resulta indoloro.

CUANDO LA HERIDA EVOLUCIONE BIEN

FUERZA A

2 DIAS/SEMANA 1-2 SERIES 8-12 REP DESCANSO 60-90 SEG

Empieza con esfuerzo 3-5/10 y una tecnica que te permita respirar



01 Sentarse y levantarse

8-12 REPETICIONES

- 1 Pies firmes y silla estable. Inclina ligeramente el tronco.
- 2 Suelta el aire al levantarte y baja con control.

CLAVE Usa las manos si lo necesitas.



02 Remo sentado con banda

8-12 REPETICIONES

- 1 Ancla la banda en un punto resistente y sin bordes cortantes.
- 2 Lleva los codos atras sin subir los hombros.

CLAVE El anclaje debe ser totalmente seguro.

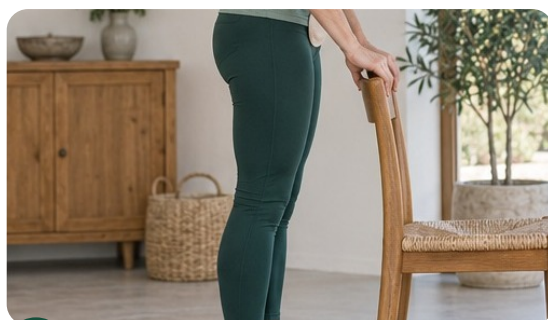


03 Empuje en pared

6-12 REPETICIONES

- 1 Manos a la altura del pecho y cuerpo alineado.
- 2 Acerca el pecho y empuja mientras expulsas el aire.

CLAVE Alejate de la pared para progresar.



04 Elevacion de talones

10-15 REPETICIONES

- 1 Sujeta una silla solo para equilibrarte.
- 2 Sube talones, pausa un segundo y baja despacio.

CLAVE Mantiene el abdomen activo sin rigidez.

TRAS CICATRIZACION Y AUTORIZACION

FUERZA B Y PROGRESION

Alterna A y B, dejando al menos 48 horas entre sesiones



01 Subida a escalon 6-10 REP POR PIERNA

- 1 Usa un escalon bajo y apoyo cercano.
- 2 Sube empujando con la pierna de arriba y baja despacio.

CLAVE No te impulses con un tirón.



02 Bisagra con botellas 8-12 REPETICIONES

- 1 Lleva caderas atrás con espalda neutra y carga cerca del cuerpo.
- 2 Vuelve de pie soltando el aire, sin retorcerte.

CLAVE Empieza con botellas pequeñas.



03 Sentadilla a silla 8-12 REPETICIONES

- 1 Cadera hacia atrás y rodillas siguiendo la dirección de los pies.
- 2 Toca la silla y sube de forma continua.

CLAVE Reduce profundidad si pierdes control.



04 Pasos laterales con banda 6-10 PASOS POR LADO

- 1 Banda ligera sobre las rodillas y semiflexión cómoda.
- 2 Da pasos pequeños manteniendo pelvis y tronco estables.

CLAVE Para si aparece tirantez abdominal.

NO EXISTE UN LIMITE UNIVERSAL DE KILOS: RESPETA TU RESTRICCIÓN QUIRÚRGICA Y PROGRESA SEGÚN TÉCNICA Y SÍNTOMAS

LA META ES VOLVER A TU VIDA

CARDIO, OCIO Y DEPORTE

Casi todas las actividades pueden retomarse con preparacion y adaptaciones



De menor a mayor demanda

01

Caminar y bicicleta estatica

10-30 min, 3-5 dias/semana. Ritmo conversacional.

02

Piscina, movilidad, yoga o pilates inicial

Solo con heridas completamente cerradas; el estoma puede mojarse.

03

Correr, clases, fuerza y deportes

Aumenta gradualmente. Para impacto o cargas altas, prepara antes el core.

Antes de salir o entrenar

- Vacía la bolsa, revisa el sellado y lleva un pequeño recambio.
- Ropa cómoda o de cintura alta puede dar confianza. Un cinturón no es obligatorio.
- En deportes de contacto, valora un protector rígido específico para el estoma.
- Si hubo herida perineal, el impacto y la sedestacion pueden necesitar mas tiempo y rehabilitacion.

PREPARARTE REDUCE IMPREVISTOS

BOLSA, HIDRATACION Y ENERGIA

La ileostomia exige especial atencion a liquidos y sales



Cuidado practico

- Vacía la bolsa antes de empezar y no esperes a que pese.
- Comprueba piel, placa y fugas. El sudor puede cambiar la adherencia.
- Lleva bolsa, placa, toallitas, bolsa de residuos y ropa de recambio.
- El soporte abdominal es opcional; si hay hernia, que lo ajuste un profesional.

Ileostomia: evita deshidratarte

- Bebe de forma repartida y aumenta la reposición con calor, sudor o actividad.
- Controla sed, mareo, calambres, palpitaciones, orina oscura o escasa.
- Si el débito es alto, solo agua puede no reponer sodio: usa la solución oral indicada por tu equipo.
- Un aumento persistente o vaciar la bolsa cada hora requiere consulta.

Antes y despues

ANTES

Toma líquidos según tu pauta. Si vas a entrenar más de 45-60 min, valora alimento tolerado y sales con tu equipo.

DURANTE

Lleva agua o bebida de rehidratación si procede. Haz pausas en calor y observa la bolsa.

DESPUES

Repone líquidos, sales y una comida con proteína y energía suficiente. No entres con síntomas de deshidratación.

AJUSTAR NO ES ABANDONAR

ADAPTA EL PLAN

01 Hernia o bulto paraestomal

No implica dejar de moverte. Reduce carga y recorrido, evita el abombamiento y busca valoración. El trabajo tipo pilates clínico ha mostrado ser viable incluso con hernia.

02 Herida perineal

Evita presión directa, sedestación prolongada e impacto hasta que cicatrice. Puede ser útil fisioterapia de suelo pélvico.

03 Quimioterapia o anemia

Acorta sesiones y baja intensidad. Si hay fiebre, mareo, falta de aire no habitual o fatiga extrema, no entrenes y consulta.

04 Neuropatía o equilibrio reducido

Usa apoyo estable, calzado cerrado y ejercicios sentados. Evita caminar solo por superficies irregulares.

05 Fugas o piel irritada

No aprietes más la bolsa para poder entrenar. Revisa el ajuste con estomatoterapia y elige una actividad que no roce la zona.

06 Dolor y fatiga

Divide 20 minutos en bloques de 5. La dosis mínima que puedes repetir vale más que una sesión que te deje agotado.

Técnica para levantar, empujar o tirar

Acerca la carga al cuerpo, coloca los pies, activa de forma suave y suelta el aire durante el esfuerzo. Evita girar mientras cargas y divide los objetos pesados en varios viajes.

PIDE AYUDA A TIEMPO

SENALES DE ALARMA

Para el ejercicio y contacta con tu equipo si algo no encaja

No entrenes y consulta

- Dolor abdominal o alrededor del estoma intenso, nuevo o que aumenta.
- Bulto nuevo duro, muy doloroso o que no disminuye al tumbarte.
- Nauseas, vomitos, abdomen hinchado, colicos y ausencia de salida por el estoma.
- Estoma muy palido, oscuro, morado o negro; sangrado abundante.
- Herida que se abre, secrecion, fiebre o empeoramiento general.
- Mareo, desmayo, palpitaciones, orina muy escasa u oscura, o debito acuoso muy alto.
- Dolor toracico o falta de aire brusca: solicita atencion urgente.

Base cientifica utilizada

Revision cerrada: septiembre de 2026. La recomendacion especifica mas reciente es EXPASS 2025.

1. **ASCN UK. EXPASS Best Practice Recommendations, 2025.**
2. **NSWOC Canada. Parastomal Hernia Best Practice Recommendations, 2022.**
3. **Memorial Sloan Kettering. Exercises After Ostomy Surgery: Level 1, 2026.**
4. **Russell S et al. Exercise and physical activity after stoma surgery: EXPASS, 2024.**
5. **MSKCC. Diet and hydration guidance for people with an ileostomy.**
6. **Plan Andaluz de Prescripcion de Ejercicio Fisico (PAPEF), 2023.**

Esta guia educa y orienta, pero no sustituye la valoracion de cirugia, enfermeria estomaterapeuta, fisioterapia o medicina. Ante dudas, adapta antes de progresar.

Objetivo final: recuperar capacidad, autonomia y confianza